Ley que modifica la Ley 30421, Ley Marco de Telesalud, para garantizar la receta electrónica interoperable y la cobertura de telesalud en zonas rurales

Complementa la Ley Marco de Telesalud para dar rango legal a la receta electrónica interoperable en todos los subsistemas, asegurar su dispensación en farmacias públicas y privadas, y priorizar la telesalud en establecimientos rurales del primer nivel.

Comisión sugerida: Salud y Población (+ Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos) ·
Prioridad: alta · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** corto
Plan Perú 2050: Salud, Desarrollo Rural, Transformación Digital

I. Exposición de motivos

La Ley 30421, Ley Marco de Telesalud, fue fortalecida por el Decreto Legislativo 1490 (2020), que definió como servicios de telesalud la teleconsulta, la teleinterconsulta, la teleorientación y el telemonitoreo. La receta electrónica se ha desarrollado principalmente por normas de menor jerarquía: la Resolución Ministerial 968-2021/MINSA aprobó una directiva de seguridad de la información en la receta electrónica para telemedicina, y la Resolución Ministerial 053-2021/MINSA aprobó una trama estandarizada de datos para la prescripción y dispensación. No obstante, no existe una obligación legal de que la receta electrónica sea aceptada en todas las farmacias y boticas del país ni de que los sistemas de EsSalud, Minsa, gobiernos regionales y privados sean interoperables para la prescripción y dispensación. Esto limita la utilidad de la teleconsulta para pacientes rurales, que deben trasladarse para obtener una receta física. Además, la telesalud depende de la conectividad y del personal disponible en el primer nivel de atención, sin un mandato de priorización territorial.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30421, LEY MARCO DE TELESALUD, PARA GARANTIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA INTEROPERABLE Y LA COBERTURA DE TELESALUD EN ZONAS RURALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto complementar la Ley 30421, Ley Marco de Telesalud, para establecer la receta electrónica interoperable con validez en todo el territorio nacional y priorizar la prestación de servicios de telesalud en los establecimientos de salud rurales del primer nivel de atención.

Artículo 2. Receta electrónica

2.1 La receta electrónica emitida por un profesional de la salud autorizado, mediante un sistema acreditado por el Ministerio de Salud y con firma digital o mecanismo de autenticación equivalente, tiene la misma validez que la receta física. 2.2 La receta electrónica puede emitirse en atenciones presenciales y de telesalud.

Artículo 3. Interoperabilidad de la prescripción y dispensación

Los sistemas de prescripción de los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos y los sistemas de dispensación de farmacias y boticas utilizan la trama estandarizada de datos aprobada por el Ministerio de Salud y se integran progresivamente con el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas.

Artículo 4. Obligación de aceptación

Las farmacias, boticas y servicios de farmacia de los establecimientos de salud del país aceptan y dispensan recetas electrónicas válidas, debiendo verificar su autenticidad mediante el servicio de validación que pone a disposición el Ministerio de Salud. La dispensación de medicamentos sujetos a fiscalización especial se rige por su normativa específica.

Artículo 5. Derechos del paciente

El paciente tiene derecho a recibir su receta electrónica en formato digital e impreso a su elección, a elegir libremente el establecimiento farmacéutico de dispensación y a que sus datos sean tratados conforme a la Ley 29733.

Artículo 6. Priorización territorial de la telesalud

El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales priorizan la implementación de servicios de teleconsulta, teleinterconsulta y telemonitoreo en los establecimientos de salud del primer nivel ubicados en zonas rurales y de frontera, articulando con la red de establecimientos de mayor capacidad resolutiva.

Artículo 7. Prohibición de inducción comercial

Los sistemas de receta electrónica no pueden inducir la dispensación en un establecimiento farmacéutico determinado ni incluir publicidad de medicamentos o establecimientos.

Artículo 8. Supervisión

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y la Superintendencia Nacional de Salud supervisan el cumplimiento de la presente ley en el marco de sus competencias.

Artículo 9. Financiamiento

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo adecúa el reglamento de la Ley 30421 a lo dispuesto en la presente ley en un plazo de noventa días hábiles, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Salud.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Gradualidad. La obligación de aceptación del artículo 4 es exigible a los doce meses de la entrada en vigor del reglamento para cadenas de farmacias y servicios de farmacia de establecimientos públicos, y a los veinticuatro meses para las demás farmacias y boticas.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Servicio de validación. El Ministerio de Salud implementa un servicio gratuito de validación de recetas electrónicas, accesible en línea y mediante código de verificación.

III. Análisis costo-beneficio

La ley eleva a rango legal herramientas ya reguladas por el Minsa (trama estandarizada, directiva de seguridad), por lo que su costo incremental es moderado y se financia con presupuestos institucionales (art. 79). Las farmacias asumen costos de adecuación tecnológica con un periodo de gradualidad. Los beneficios son evitar traslados de pacientes rurales para obtener recetas físicas, reducir errores de lectura y falsificación de recetas, mejorar la trazabilidad de antimicrobianos y medicamentos controlados, y generar datos de consumo de medicamentos para la gestión sanitaria. La prohibición de inducción comercial protege la libre elección del paciente.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Complementa la Ley 30421, Ley Marco de Telesalud, modificada por el Decreto Legislativo 1490; se articula con la Ley 30024, la Ley 26842 y la Ley 29733.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, la receta electrónica es aceptada por el 100% de servicios de farmacia públicos y cadenas de farmacias, y al menos el 50% de establecimientos rurales del primer nivel brindan teleconsulta o teleinterconsulta.

Normas relacionadas

• Ley 30421, Ley Marco de Telesalud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30421.pdf

• Decreto Legislativo 1490, que fortalece los alcances de la Telesalud (ficha UNEP-LEAP) — https://leap.unep.org/en/countries/pe/national-legislation/decreto-legislativo-no-1490-decreto-legislativo-que-fortalece-los

• Resolución Ministerial 968-2021/MINSA, Directiva de seguridad de la información en la receta electrónica para Telemedicina — https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-directiva-administrativa-que-establece-los-mecanism-resolucion-ministerial-n-968-2021minsa-1977314-1

• Ley 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30024.pdf

• Ley 26842, Ley General de Salud — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26842.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Chile: Ley 21.541, que autoriza a los prestadores de salud a efectuar atenciones mediante telemedicina (2023) — https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1190336

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2025/327 relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj

Fuentes

• OMS: Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025 — https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924

• HL7 FHIR, especificación vigente — https://www.hl7.org/fhir/

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/TAL-07.html